

WEEKLY REPORT



教學部 週戰報

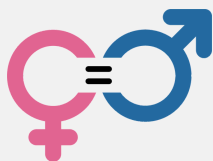
做夢的勇氣 實現的能力 創造360度醫學人生

FRIENDLINESS



友善

EQUITY



公平

ARTISTRY



藝術

INSIGHT



洞察

為部屬加值，讓組織成為價值的放大器

在多數組織中，「為部屬加值」常被理解為主管給員工更多資源，如培訓課程、獎金激勵、升遷機會。然而，真正的加值並非「由上而下」的賞賜，而是一種「由內而外」的賦能。它的本質，不在於給予什麼，而在於**創造能讓人不斷成長、產生價值的環境**。

在醫院這樣高度專業的生態裡，無論是醫療人員、行政人員，甚至清潔與支援單位的同仁，每個角色都有獨特的價值。真正的「加值」，就是讓這些潛能被看見、被連結，最終轉化為整體組織的競爭力。

根據《經理人》雜誌提出的觀點，有效的管理者懂得「為部屬的工作加值」，**透過明確授權、及時回饋、清楚目標與開放溝通**，讓工作更有方向。「加值」不能只停留在讓人「做得更好」，更要讓人「成為更好的人」。

真正高階的加值包含三個層次：

- **工具層的賦能**：給予能提升效率的資源。例：開放AI工具輔助，減少醫療人員知識不平等的差異。
- **思維層的開展**：重新定義問題與創新思維。例：透過設計思考流程，讓團隊共同重新設計就醫動線。
- **意義層的共鳴**：讓每個人感受到工作的使命與影響。例：近期奇美暖心角陳設著「醫療故事牆」，分享了醫療人員的小行動如何改變病人的生命。

這三個層次構成了價值共創：從個人能力的提升，進而推動團隊協作，最終回饋整個醫療體系。然而，落實為部屬加值並不容易。醫院是嚴謹、講求標準化與安全的組織，而加值的過程往往需要「試驗與學習」。這兩者之間的張力，**需要透過文化與制度來調和**。首先，加值不是放任，而是引導。管理者要設定清晰的邊界，讓成員在**安全的範圍內探索新方法**，因為真正能支撐加值文化的，**是一個兼具心理安全感、敏捷與韌性的環境**；例如推動「小規模的創新嘗試」，允許科室以可控的風險嘗試改進方案。其次，加值不是附加，而是融入。與其額外開設一門「學習課程」，不如讓學習融入日常，讓會議中有反思、讓工作中有分享、讓回饋中有成長。

當組織的文化能鼓勵每個人去思考：「我能怎麼讓我的工作更有價值？」時，加值就不再是管理策略，而是一種習慣、一種氛圍。最終，我們會發現：加值不只是讓員工變強，更是讓整個系統變聰明；不只讓工作更順，而是讓醫療更有溫度。





災難醫療救助

大林慈濟醫院急診部 李宜恭主任



「大家以為我是去付出的，但我其實是在接受生命教育的。」李宜恭主任的開場白令人出乎意料。空氣中頓時瀰漫著一種難以名狀的靜謐，這個論述，徹底翻轉了我們對「救援」的想像。

二十年來，李主任的足跡遍布世界。1999年臺灣921大地震的斷層帶、阿里山森林鐵路事故的深谷、2004年南亞海嘯後滿目瘡痍的海岸線、2015年尼泊爾震後的加德滿都古城。在每一個災難現場，他不只是一位施救者，更是一個謙卑的學習者。他說，當你在瓦礫堆中看見一位母親用身體護住孩子的遺體，當你目睹一個失去雙腿的青年仍對你微笑致謝，你才會懂得什麼叫做「生命的重量」。

這些經驗，成為他在急診室夜班時最深沉的力量來源。每當面對難纏的病人及家屬、處理不完的文書作業、永遠響個不停的鈴聲，他會閉上眼睛，想起那些在帳篷醫院裡，連最基本的止痛藥都缺乏的災民。於是，眼前的困難變得渺小了。這就是他口中的「充電」，不是逃避現實，而是在更巨大的苦難中，重新校準自己對困難的定義。

李主任也詮釋了見苦知福四個字，不只是陳腔濫調的心靈雞湯，而是真正的清醒。

他說，唯有親眼見證過生命的脆弱與堅韌，才能在日復一日的工作中，重新燃起那份助人的熱情，這份在瓦礫堆中找回的深刻體悟，便是「見苦知福」的真實寫照，讓我們猛然驚覺日常的平安是何等珍貴的幸福。

這份力量的根源，來自於「同體大悲」的信念，這是一種跨越血緣、國籍與宗教的同理心，將素不相識的災民視為至親，感受他們的苦痛，並化為實際行動，這也是支持所有志工無悔投入的溫暖基石。然而，滿腔熱血更需智慧同行，李主任的分享，讓我們理解國際援助絕非易事，其中充滿了挑戰與細膩的應對。

例如，在不同宗教文化的國度，為了讓援助順利推行，團隊必須放下自身的標誌，甚至將「臺灣」字樣移除，因為他們深知，人道精神的本質是無私，遠超越任何標籤。

最後，李主任以「能助人的人，就是有福的人；能救人的人，就是菩薩」與我們共勉，期盼這場分享能化為我們心中的一盞明燈，在迷惘時照見行醫的初衷。



ROB 2.0／CEBM／CASP評讀(RCT)

證據等級不等於證據品質

NAME：黃博裕醫師

黃博裕醫師透過課程向大家分享了一個重要觀念：隨機對照試驗（RCT）在牛津實證醫學中心的證據等級中屬於第二級（LEVEL 2）的高等級證據，僅次於系統性綜述或META分析（LEVEL 1），但等級高並不保證品質好，真正的關鍵在於這份研究是否成功避免了各種偏誤。



為什麼偏誤如此重要？

偏誤是一種系統性的錯誤，它會讓研究結果偏離真相。更麻煩的是，這種誤差無法透過統計方法校正。想像一把刻度不準的尺，無論測量多少次，得到的數據都會系統性地偏差——這就是偏誤的本質。

RCT的設計優勢

隨機對照試驗之所以被重視，是因為它具備三項關鍵設計

- 對照組：提供比較基準
- 隨機分派：平衡已知與未知的干擾因素
- 因果推論能力：能較確切地建立因果關係



選對評讀工具才能看出門道

ROB 2.0(偏誤風險評估工具2.0版)

適用於評估研究本身的內部效度

是 COCHRANE 系統性文獻回顧評估隨機對照試驗偏誤風險的標準工具，主要關注研究的內部效度。它檢視**五個領域**：隨機分派過程、介入執行、缺失結果資料、結果測量，以及選擇性報告。根據規則，若任何一個領域被判定為『高風險』，整體評估即為高風險；若所有領域均為低風險，整體才是低風險；若有一個或多個領域為『有些疑慮』，則整體為『有些疑慮』。

最危險的陷阱:精準但不正確

最容易誤導醫療決策的，往往不是小型、結果分散的研究，而是那些樣本數大、結果集中，但實際上充滿偏誤的觀察性研究。這類研究因為隨機誤差小(統計上看起來很「精準」)，反而更容易讓人誤以為結果可靠。卻不知整個研究方向可能從一開始就偏離了真相。

因此，臨床決策必須奠基於低偏誤、高品質的證據，而不是僅僅追求大樣本或統計顯著性。

CASP或CEBM評讀工具

除了檢視研究的內部效度外，還會進一步評估外部效度，也就是**研究結果能否應用到真實的臨床情境**。它們的架構通常包括三個層面：研究設計是否嚴謹可信（內部效度）、研究結果本身的意義，以及研究結果是否適用於我的病人（外部效度）。因此，當臨床人員需要判斷『這個研究結果能否應用於我的病人？』時，CASP 或 CEBM 的工具特別有幫助。

破繭而出

在挑戰中的學習：年會籌辦點滴

分享者：教學部 依玲



臺灣醫事聯合臨床技能發展學會的年會辦理是我每年最重要的任務之一，今年**首次**以一整天議程進行，並新增會員禮品發放與當日海報論文口頭報告評選，同時**挑戰無紙化**，改以**視覺化網頁**取代紙本大會手冊，這些新嘗試，讓今年的籌劃格外具有挑戰性與突破性。

在長達數月的籌備過程中，從海報論文徵稿與OSCE教案甄選的活動宣傳、收稿、評分共識，到研討會講師聯絡、各職類學分申請與報名通知等，每個階段都有不同挑戰，也伴隨焦慮與不斷調整，但最終仍能順利完成，仰賴許多人共同的努力。特別感謝理事長蘇慧真部長明確果斷的指示，使方向清晰；秘書長黃淑芬組長、副秘書長黃建中組長與徐富美督導，以及財務長劉雯副部長的經驗指導，更是穩固後盾；常務理事楊浚銘主任(前任秘書長)與監事張鈴艷總技師不吝給予建議，使細節更臻完善，更要感謝視聽中心與同事們鼎力相助，大家分工協力，才能在9月20日年會當天讓230位與會者都能感受到我們的用心，活動得以順利完成。

今年挑戰以視覺化網頁取代過往紙本大會手冊，雖仍有許多可改進之處，但我提醒自己：**學了就要勇於應用，唯有不斷嘗試才能進步**。謝謝同事們在會後提供寶貴建議，讓我們有機會在下一次做得更好，每年的年會都是一次新的學習，這些累積讓我所負責的業務逐步精進，也期許自己能年年有所進步，努力比過去的自己更好一點。



領導力專家 - 約翰·麥斯威爾

LEADERSHIP IS NOT ABOUT TITLES,
POSITIONS, OR FLOWCHARTS. IT IS
ABOUT ONE LIFE INFLUENCING ANOTHER.

領導無關職稱、職位或是流程圖，
而是一個生命影響了另一個生命。